

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala de Gravedad de Síntomas del TEPT-Revisada (EGS-R)

Eje I • Versión de trabajo: 10 de septiembre de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

Familia / sigla	EGS-R
Nombre completo	Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático-Revisada
Versión / edición	Versión revisada según criterios DSM-5, 31 ítems.
Idioma	Español (España); desarrollada originalmente en español, no es una traducción.
Autores (original)	Echeburúa, E., Amor, P. J., Sarasua, B., Zubizarreta, I., Holgado-Tello, F. J., & Muñoz, F. (2016).
Año (original / adaptación)	2016 (no aplica adaptación; instrumento desarrollado originalmente en español).
Eje primario	Eje I — Problemas, síntomas y riesgo
Etiquetas	TEPT; trauma; intrusión; evitación; hiperactivación; disociación; disfuncionalidad.
Pregunta clínica que responde	¿Cuál es la gravedad de los síntomas de TEPT según criterios DSM-5, incluyendo componentes disociativos y el grado de disfuncionalidad asociada?
Población	Adultos expuestos a sucesos traumáticos.
Contexto de aplicación	Evaluación clínica hospitalaria, peritajes psicológicos forenses, centros de atención a víctimas de violencia de género, atentados y accidentes graves.
Informante	Entrevista clínica estructurada o autoinforme.
Modalidad de administración	Entrevista o autoadministrado; 15-20 minutos.
Número de ítems	31 ítems totales: 21 de gravedad sintomática + 4 de especificación disociativa + 6 de disfuncionalidad (verificado en la ficha técnica fuente).
Periodo temporal de referencia	No verificado en las fuentes consultadas más allá de lo indicado en la escala de respuesta (frecuencia semanal).
Formato de respuesta	Los primeros 21 ítems en escala Likert de 4 puntos (0 = nada a 3 = 5 o más veces por semana / extremadamente); las secciones de disociación y disfuncionalidad se puntúan de forma separada.

Tiempo estimado de aplicación	15 a 20 minutos (declarado en la ficha técnica fuente).
Regla de puntuación	Puntuación total de gravedad = suma directa de los primeros 21 ítems (rango 0-63), organizados en 4 criterios DSM-5: Intrusión/Criterio B (ítems 1-5), Evitación/Criterio C (6-7), Alteraciones cognitivas y de ánimo/Criterio D (8-14), Hiperactivación/Criterio E (15-21). Especificación disociativa (ítems 22-25) y disfuncionalidad/Criterio G (ítems 26-31) se puntúan aparte.
Ítems invertidos	No se identificaron ítems invertidos en la ficha técnica fuente.
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado en las fuentes consultadas.
Rango posible	0-63 (escala de gravedad de 21 ítems); subescalas de disociación y disfuncionalidad con rango propio no especificado numéricamente en la ficha fuente.
Puntos de corte	La ficha técnica fuente indica que una puntuación de gravedad (ítems 1-21) de 20 o más puntos sugiere la presencia clínica de TEPT según DSM-5; no se verificó de forma independiente contra el artículo original (Terapia Psicológica, 2016) en esta sesión.
Activos disponibles	Protocolo.pdf (formulario de 31 ítems, copiado desde Downloads/Instrumentos/Eje I/EGS_R/EGS_R_Scale.pdf de la raíz del proyecto). Ficha_Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto.
Estado QA	Familia nueva, incorporada 2026-09-10 desde carpeta suelta de la raíz. Ficha construida a partir de EGS_R_Ficha.pdf (carpeta suelta) y verificación directa del formulario administrable. No se verificó independientemente el artículo original (Terapia Psicológica, 2016) contra fuente primaria en esta sesión. Complementa la familia Eje I/IES-R (autoinforme de impacto subjetivo) con una evaluación de gravedad sintomática alineada a criterios DSM-5 completos. Requiere revisión humana antes de uso clínico, dado el contenido sobre eventos traumáticos.
Fecha	2026-09-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana

Versión de la ficha	1.0
---------------------	-----

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: gravedad de los síntomas del TEPT según los cuatro criterios sintomáticos del DSM-5 (intrusión, evitación, alteraciones cognitivas/de ánimo, hiperactivación), más especificación disociativa y disfuncionalidad asociada.

Finalidad: evaluar la presencia y gravedad de los síntomas de TEPT en víctimas adultas de sucesos traumáticos, con perfil por criterio para guiar el plan terapéutico.

Usos apropiados

Evaluación clínica y forense de la gravedad del TEPT en adultos con un evento traumático identificado.

Complemento a IES-R (impacto subjetivo) cuando se requiere alineación explícita con los criterios diagnósticos DSM-5 completos, incluyendo disociación y disfuncionalidad.

Usos NO apropiados

Aplicarla sin haber identificado previamente con claridad el suceso traumático de referencia (requisito señalado en la ficha técnica fuente).

Uso forense sin escalas complementarias de sospecha de simulación, según recomienda la propia ficha técnica fuente.

9. Adaptación cultural y norma local

Desarrollada originalmente en español por el grupo de Echeburúa; la ficha técnica fuente reporta alfa de Cronbach de 0.91 para la gravedad total y entre 0.73-0.85 para las subescalas, con validez convergente frente al Inventario de Depresión de Beck y escalas de fobia social. No verificado de forma independiente contra el artículo original en esta sesión.

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

La rememoración de eventos traumáticos durante la evaluación puede generar malestar psicológico; asegurar un encuadre terapéutico seguro y de apoyo (recomendación de la ficha técnica fuente).

No sustituye una evaluación clínica estructurada ni el juicio profesional.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

Publicada en Terapia Psicológica (revista académica). No se verificó de forma independiente en esta sesión la licencia exacta de reproducción del instrumento completo — no verificado, revisar antes de distribución masiva o uso comercial.

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Echeburúa, E., Amor, P. J., Sarasua, B., Zubizarreta, I., Holgado-Tello, F. J., & Muñoz, F. (2016). Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático según el DSM-5 (EGS-R): Propiedades psicométricas. *Terapia Psicológica*, 34(2), 111-128.